# 非典型的形態を呈し、鑑別に苦慮した心臓腫瘍の 1 例

◎北川 健太[1)]、新保 美穂[1)]、中出 慧[1)]、上野 剛志[1)]、金森 隆樹[1)]
富山県厚生農業協同組合連合会 高岡病院[1)]

【はじめに】原発性心臓腫瘍は約 75～85%が良性腫瘍で、粘液腫、脂肪腫、乳頭状線維弾性腫などがある。また左房粘液腫は最も多い良性心臓腫瘍であり、約 50%を占める。今回我々は、脳梗塞を契機に発見され特異な形態から鑑別に苦慮した心臓腫瘍の 1 例を経験したため報告する。

【症例】57 歳、男性　　【主訴】呂律不良

【既往歴/併存症】なし

【現病歴】20XX 年 6 月 呂律不良を職場で指摘されたため救急受診。神経診察で運動性失語を認め、頭部 CT では右前頭葉皮質の不明瞭化および前頭葉一部に低吸収域を認め急性期脳梗塞と診断し、同日入院。長期の喫煙歴および高血圧の指摘などアテローム血栓素因を認め、心電図で心房細動等を認めないため非心原性脳梗塞として加療となった。

【来院時心電図所見】洞調律（74bpm）、ST-T 変化なし

【超音波所見】心原性脳梗塞の除外目的にて第六病日に心臓超音波を行った結果、左房内、卵円窩に付着する 3～4cm の可動性構造物を認めた。ベッド仰臥位による検査施行のため有茎性の有無は描出困難であったが、形態は紐状で嵌頓所見は認めなかった。また左房内血栓も考えられた。

【経過】多発脳梗塞を発症しており心原性塞栓と考えられ、経食道心臓超音波検査も検討されたが、再塞栓症のリスクが極めて高く致死的となる可能性があるため早急に緊急手術が必要と判断された。第八病日に心臓超音波検査と頭部 CT 再検となり、同日胸腔鏡下左房内腫瘍切除術が施行された。

【考察】本症例の可動性構造物は紐状を呈していたため、ランブル疣贅や乳頭状線維弾性腫も鑑別にあがったが弁や弁近傍の心内膜からではなく、卵円窩付近から起始する可動性構造物であった。腫瘤の性状も脆弱であり左房から左室への順方向血流による持続的な牽引で形態が引き延ばされ紐状となることも推測された。

【まとめ】非典型的形態を呈し、左房内血栓や索状病変などとの鑑別に苦慮した心臓腫瘍の 1 例を経験した。臨床側への迅速な情報提供を行ったことで、再塞栓症などの病態悪化を防ぐことに繋がった。